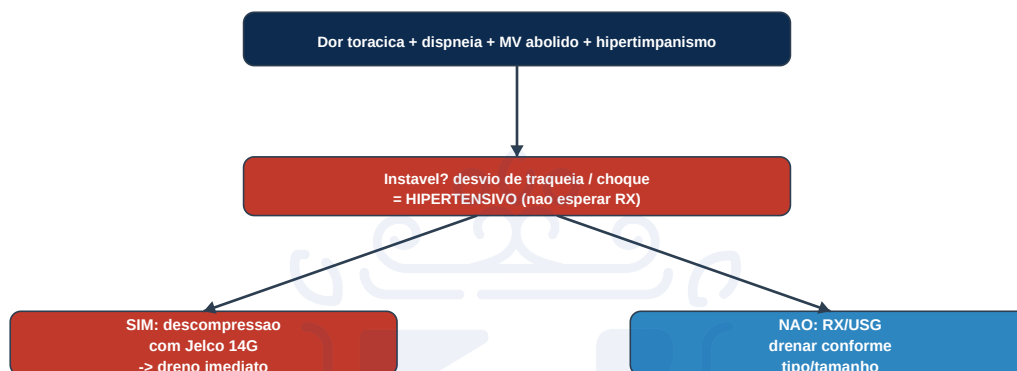


PNEUMOTÓRAX — SIMPLES, ABERTO, HIPERTENSIVO

FLUXOGRAMA — ESTÁVEL x HIPERTENSIVO

PNEUMOTÓRAX — HIPERTENSIVO É CLÍNICO



DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O QUE É

- Presença de ar entre o pulmão e a parede torácica
- SIMPLES: espontâneo primário, espontâneo secundário, traumático, iatrogênico
- ABERTO: comunicação direta entre o ar ambiente e a cavidade pleural ('ferida soprante')
- HIPERTENSIVO: ar sob pressão -> desvio mediastinal -> choque -> PCR (emergência)

QUANDO SUSPEITAR E EXAME FÍSICO

PISTAS

- Dor torácica súbita ventilatório-dependente + dispneia; trauma/procedimento recente (CVC, toracocentese, VM)
- Doença pulmonar prévia (DPOC, asma, fibrose, TB) ou episódios prévios; tabagismo
- Inspeção: assimetria, redução da expansibilidade unilateral; ferida soprante (aberto)
- Percussão: HIPERTIMPANISMO; Ausculta: MV reduzido/abolido ipsilateral
- Enfisema subcutâneo pode estar presente

RED FLAGS — PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

DIAGNÓSTICO CLÍNICO — NÃO ESPERAR RX

- Instabilidade hemodinâmica, hipotensão, taquicardia persistente
- Hipoxemia refratária, rebaixamento; DESVIO DE TRAQUEIA, turgência jugular
- PCR tipicamente em AESP
- Conduta IMEDIATA: descompressão com Jelco 14G no 2o EIC linha hemiclavicular OU 4o/5o EIC linha axilar anterior
- Medida TEMPORÁRIA -> drenagem torácica IMEDIATA após. NÃO transferir apenas com o Jelco

CONDUTA POR TIPO

Tipo	Conduta
Espontâneo primário	Pequeno/pouco sintomático: O2 + observação. Grande/sintomático: drenagem + cirurgia torácica (pleurodese)
Espontâneo secundário	Mais grave: limiar BAIXO para drenagem + internação + avaliação precoce
Traumático	Visível no RX ou paciente intubado -> DRENAR. Pequeno só na TC: conservador + internar (observar 24-48h)
Iatrogênico	Drenar se intubado/sintomático/grande no RX; conservador se pequeno e assintomático (observação hospitalar)
Aberto	Curativo OCLUSIVO de 3 PONTAS (válvula) -> drenagem + fechamento cirúrgico

PRESCRIÇÃO BÁSICA E EXAMES

Rx PACIENTE ESTÁVEL

Oxigênio suplementar (manter SatO2 > 94%) — acelera a reabsorção do ar
Analgesia: Dipirona 1g EV 6/6h (ou paracetamol/AINE); opioide se dor intensa (tramadol/morfina)
Repouso relativo + monitorização contínua
Exames (se estável): RX de tórax PA; USG à beira-leito (POCUS); TC de tórax = padrão-ouro
Drenagem em selo d'água conforme o tipo/tamanho

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- INTERNAR: secundário, traumático, iatrogênico moderado/grande, sintomático, em VM, necessidade de dreno, observação pós-trauma 24-48h
- ALTA: assintomático, RX sem piora em 24-48h, SEM dreno, orientações de alarme e seguimento ambulatorial definido
- Orientações: evitar esforço físico; NÃO voar nem mergulhar por 2-4 semanas
- Retornar imediatamente se: dor torácica, falta de ar, tosse intensa
- Sempre estabilizar (drenar se necessário) ANTES de transferir

CHECKLIST

NÃO ESQUECER

- ☐ Reconhecer pneumotórax hipertensivo pela CLÍNICA (não esperar RX) e descomprimir
- ☐ Após descompressão por agulha, drenar sempre
- ☐ Pneumotórax aberto: curativo de 3 pontas antes do dreno
- ☐ Definir tipo (espontâneo/traumático/iatrogênico) para decidir drenar x observar
- ☐ Não transferir paciente apenas com Jelco / sem estabilizar

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Pneumotórax ____ (espontâneo/traumático/secundário/hipertensivo) à ____ (direita/esquerda).
- Padrão respiratório: ____; SatO2 ____ (ar ambiente/O2 ____); estabilidade hemodinâmica: ____.
- Drenado: sim/não; descompressão por agulha realizada: sim/não.
- Necessita avaliação de cirurgia torácica para tratamento definitivo/seguimento.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente politraumatizado com dispneia grave, hipotensão, MV abolido à direita, hipertimpanismo e desvio de traqueia. Conduta imediata?

- A) Solicitar radiografia de tórax antes de qualquer medida
- B) Descompressão imediata com agulha (Jelco 14G) seguida de drenagem torácica
- C) Apenas oxigênio e observação
- D) Intubar e aguardar a tomografia
- E) Curativo de 3 pontas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a conduta imediata no pneumotórax ABERTO?

- A) Selar a ferida completamente nos 4 lados
- B) Curativo oclusivo de 3 pontas (permite saída do ar e impede a entrada)
- C) Apenas observação
- D) Toracotomia imediata
- E) Não intervir até a radiografia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Pneumotórax traumático visível na radiografia ou paciente intubado. Conduta?

- A) Observação domiciliar
- B) Drenagem torácica
- C) Apenas oxigênio
- D) Curativo de 3 pontas
- E) Alta com analgésico

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo, é correto:

- A) Depende da radiografia para confirmação
- B) É clínico — não se deve aguardar a radiografia para descomprimir
- C) Exige tomografia de urgência
- D) Só ocorre em trauma penetrante
- E) Cursa com hipertensão arterial

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual orientação de alta é correta após pneumotórax?

- A) Pode voar e mergulhar imediatamente
- B) Evitar esforço físico e não voar/mergulhar por 2-4 semanas, retornando se dor/dispneia
- C) Retomar atividades de mergulho no dia seguinte
- D) Não há restrições
- E) Repouso absoluto por 6 meses

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O quadro é de pneumotórax hipertensivo — diagnóstico clínico. A conduta imediata é a descompressão por agulha (Jelco 14G, 2o EIC hemiclavicular ou 5o EIC axilar anterior), medida temporária, seguida de drenagem torácica. Não se aguarda RX.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No pneumotórax aberto, aplica-se curativo oclusivo de 3 pontas, que funciona como válvula (deixa o ar sair na expiração e impede a entrada na inspiração), seguido de drenagem e fechamento cirúrgico definitivo.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Pneumotórax traumático visível no RX ou em paciente intubado deve ser DRENADO. Apenas pneumotórax pequeno visto só na TC pode ser conduzido conservadoramente, com internação e observação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O pneumotórax hipertensivo é diagnóstico CLÍNICO (dispneia, MV abolido, hipertimpanismo, choque, desvio de traqueia); não se deve aguardar a radiografia — a descompressão é imediata.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Após pneumotórax, orienta-se evitar esforço físico e NÃO voar nem mergulhar por 2-4 semanas (variação de pressão pode reexpandir/agravar), retornando ao PS se dor torácica ou dispneia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico